COLEÇÃO / MATERIAL 04

Cansado(a), mas não consigo dormir

Entenda o ciclo da insônia e conheça medidas iniciais que podem ajudar.

UMA IDEIA PARA LEVAR COM VOCÊ

Sono não é uma prova de desempenho. Quanto mais você o força, mais vigilante pode ficar.

POR QUE ESTE MATERIAL EXISTE

Você está exausto(a), deita e a mente desperta? A insônia pode envolver um estado de alerta aprendido, preocupações com o sono e hábitos que reforçam o tempo acordado na cama.

Você pode ler aos poucos. Não precisa fazer todas as atividades e não existe pontuação para acertar.

Uma dificuldade • Uma ideia • Uma pequena experiência

01 / ENTENDER

O que pode estar acontecendo?

Dormir depende de processos biológicos e comportamentais. Em insônia crônica, a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) é tratamento de primeira linha. Higiene do sono pode ajudar, mas isoladamente costuma ser insuficiente para tratar o quadro.

Como o ciclo pode se manter

- Uma ou mais noites ruins aumentam a preocupação com dormir.
- A pessoa passa mais tempo na cama tentando compensar ou monitorando o relógio.
- A cama pode se associar à vigília e à frustração.

Três estratégias para experimentar

01 Regularidade gentil

Procure manter horário de acordar relativamente consistente, considerando sua saúde, sua rotina e a necessidade de sono.

Exemplo: evitar grandes mudanças no despertar entre os dias da semana.

02 Não transforme a cama em local de luta

Se permanecer acordado(a) gerar frustração, experimente sair temporariamente do quarto e fazer algo tranquilo, com pouca luz, voltando quando houver sonolência.

Exemplo: ler um texto leve fora da cama até sentir sono.

03 Reduza sinais de alerta

Observe cafeína tardia, trabalho na cama e checagem constante do horário. Reduzir esses estímulos pode tornar o ambiente mais favorável.

Exemplo: virar o relógio para não monitorar minutos durante a noite.

02 / COLOCAR EM PRÁTICA

Uma mudança para esta semana

Escolha esse experimento somente se fizer sentido para você. Ele pode ser adaptado, interrompido ou feito com apoio.

01 Identifique um fator que esteja prolongando a vigília noturna.

02 Escolha apenas uma mudança comportamental viável.

03 Observe se a relação com o momento de deitar fica menos tensa; não exija dormir imediatamente.

Na vida real

EXEMPLO

“Quando acordo, confiro as horas cinco vezes e fico irritado(a).” Experimento: deixar o visor do relógio fora do campo visual.

Plano B: se estiver difícil

Se a noite for ruim, evite compensações extremas ou se culpar. Volte ao plano com flexibilidade e procure avaliação se o problema persistir.

Quando pedir ajuda

Insônia frequente com prejuízo diurno merece avaliação. Ronco intenso, pausas respiratórias, sonolência ao dirigir, agitação intensa ou sintomas de humor também precisam ser investigados. Restrição de sono deve ser orientada individualmente por profissional capacitado.

03 / ESCOLHER, NÃO SE COBRAR

Checklist opcional

Este checklist é um cardápio de possibilidades, não uma lista de obrigações. Marque só o que fez sentido — ou não marque nada.

☐ Evitei monitorar o relógio repetidamente.

☐ Percebi um hábito que mantém meu estado de alerta.

☐ Testei uma mudança sem exigir resultado imediato.

☐ Mantive o quarto mais associado ao descanso.

☐ Considerei buscar TCC-I se a insônia é persistente.

Uma estratégia que quero testar

Minha dificuldade principal é:

_____

O menor passo que consigo imaginar é:

_____

O que poderia facilitar esse passo:

_____

Leituras e referências

• AASM. Tratamentos psicológicos e comportamentais para insônia crônica (2021).
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7853203/

• American College of Physicians. Clinical guideline for chronic insomnia.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27136449/

Material educativo para adultos; não substitui avaliação, diagnóstico, prescrição ou cuidado individualizado. Reproduza com responsabilidade e revise para seu público.